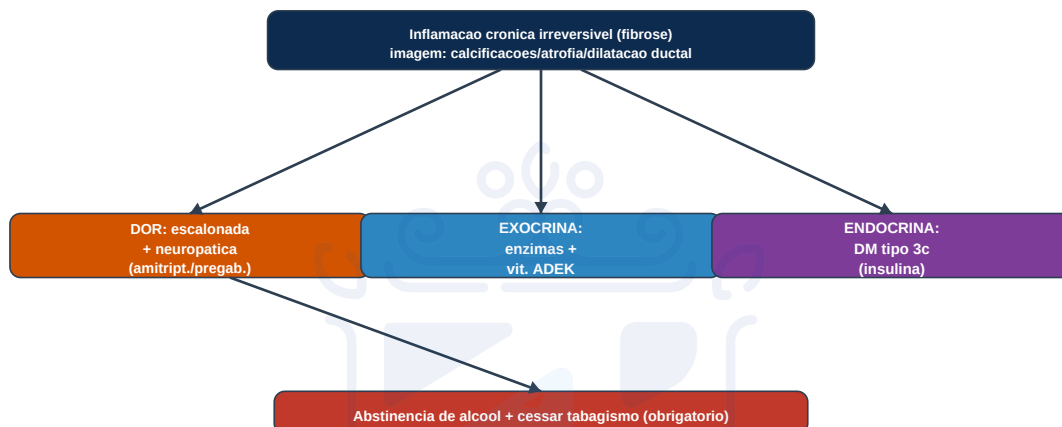


PANCREATITE CRÔNICA — DOR + IPE + DM 3c

FLUXOGRAMA — TRÊS FRENTES

PANCREATITE CRÔNICA — DOR, EXÓCRINA E ENDÓCRINA



DEFINIÇÃO E ETIOLOGIA (TIGAR-O)

DOENÇA CRÔNICA IRREVERSÍVEL

- Inflamação persistente com fibrose irreversível -> perda estrutural e funcional, dor crônica, má digestão, desnutrição e diabetes pancreatogênico (CID K86.1)
- TIGAR-O: Tóxico-metabólica (ÁLCOOL principal; tabagismo acelera independentemente), Idiopática, Genética (PRSS1/SPINK1/CFTR), Autoimune (IgG4), Recorrente, Obstrutiva
- Dor: epigástrica, profunda, irradiada ao dorso, pós-prandial, alívio ao inclinar para frente; pode tornar-se neuropática centralizada
- Insuficiência exócrina (IPE): esteatorreia (> 7 g/dia), diarreia, perda ponderal, deficiência de vitaminas lipossolúveis
- Insuficiência endócrina: diabetes tipo 3c (alta variabilidade, hipoglicemias, má resposta a orais)

DIAGNÓSTICO

IMAGEM + FUNCIONAL

- Imagem (base): TC contrastada (calcificações, atrofia, dilatação ductal); RM/MRCP (ductal detalhado); EUS na doença precoce (critérios de Rosemont)
- Funcional exócrina: elastase fecal < 200 µg/g = insuficiência; < 100 µg/g = grave
- Funcional endócrina: glicemia, HbA1c
- Diferenciar dor nociceptiva x neuropática (muda o tratamento)
- Rastrear complicações e risco aumentado de câncer de pâncreas

MANEJO DA DOR — ESCALONADO

Rx SIMPLES -> NEUROPÁTICO -> REFRATÁRIO

Simples: Dipirona 1 g VO/EV 6/6h; Paracetamol 750-1000 mg 6-8/8h

Opioides fracos: Tramadol 50-100 mg 8/8h; Codeína 30-60 mg 6/6h

Dor NEUROPÁTICA (essencial): Amitriptilina 10-25 mg à noite (até 75 mg); Gabapentina 300 mg/noite titulando até 8/8h;

Pregabalina 75-150 mg 12/12h

Refratária: opioide forte (cautela); bloqueio do plexo celíaco (EUS-guiado); avaliação cirúrgica precoce

EVITAR AINE crônico; abstinência de álcool e cessação do tabagismo são OBRIGATÓRIAS

INSUFICIÊNCIA EXÓCRINA E ENDÓCRINA

Frente	Conduta
Exócrina (IPE)	Reposição enzimática pancreática; dieta normocalórica/hiperproteica fracionada (5-6x); NÃO restringir gordura se enzimas adequadas; repor vit. A/D/E/K, cálcio+D, zinco/Mg
Endócrina (DM 3c)	Preferir INSULINA (basal-bolus/NPH); alto risco de hipoglicemia; EVITAR sulfonilureias; metformina só se tolerada e sem desnutrição
Endoscopia	Cálculos/estenoses ductais, drenagem de pseudocisto, bloqueio do plexo celíaco
Cirurgia	Dor refratária, ducto dilatado, complicações: Puestow, Frey, Beger (melhora dor/qualidade de vida)

AGUDIZAÇÃO NA EMERGÊNCIA + COMPLICAÇÕES

NO PS

- Agudização: analgesia EV, hidratação venosa, antieméticos, jejum relativo
- EXCLUIR pancreatite aguda, pseudocisto e infecção (não atribuir tudo à dor crônica)
- Complicações: pseudocistos, estenose biliar, trombose esplênica, ascite pancreática, osteopenia, CÂNCER de pâncreas
- Controle glicêmico cuidadoso (risco de hipoglicemia no DM 3c)
- Apoio multidisciplinar; educação sobre a cronicidade da doença

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente ____ anos com pancreatite crônica (etiologia ____) em agudização dolorosa / complicação ____.
- Dor ____ (nociceptiva/neuropática) refratária; vômitos ____; icterícia ____; glicemia ____.
- Condutas: analgesia EV ____, hidratação, antiemético; exclusão de pancreatite aguda/pseudocisto/infecção.
- Solicito avaliação de gastro/cirurgia (dor refratária, possível endoscopia/cirurgia) ± UTI; transporte com monitorização e atenção a hipoglicemia.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é a principal causa de pancreatite crônica, e qual fator acelera a progressão de forma independente?

- A) Hipertrigliceridemia; obesidade
- B) Álcool (principal); tabagismo (fator independente)
- C) Litíase biliar; sedentarismo
- D) Autoimune; dieta
- E) Genética; cafeína

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual exame funcional confirma insuficiência pancreática exócrina?

- A) Amilase sérica
- B) Elastase fecal $< 200 \mu\text{g/g}$ ($< 100 = \text{grave}$)
- C) Lipase sérica
- D) HbA1c
- E) Bilirrubina total

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Sobre o diabetes pancreatogênico (tipo 3c) na pancreatite crônica, é correto:

- A) Tratar preferencialmente com sulfonilureias
- B) Preferir insulina, com atenção ao alto risco de hipoglicemia e evitando sulfonilureias
- C) Não necessita tratamento
- D) Metformina em altas doses para todos
- E) É idêntico ao DM tipo 1 no manejo

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

No manejo da dor neuropática da pancreatite crônica, qual classe é essencial?

- A) AINEs em uso crônico
- B) Antidepressivos tricíclicos (amitriptilina) e/ou gabapentinoides (gabapentina/pregabalina)
- C) Corticoides orais
- D) Antibióticos
- E) Inibidores de bomba de prótons isolados

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Paciente com pancreatite crônica conhecida chega ao PS com agudização dolorosa. Além de analgesia e hidratação, o que é fundamental?

- A) Atribuir toda a dor à doença crônica e dar alta
- B) Excluir pancreatite aguda, pseudocisto e infecção
- C) Iniciar antibiótico de rotina
- D) Suspender insulina
- E) Indicar cirurgia imediata em todos

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

O álcool é a principal causa de pancreatite crônica, e o tabagismo acelera a progressão de forma independente — daí a abstinência alcoólica e a cessação do tabagismo serem obrigatórias.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A elastase fecal $< 200 \mu\text{g/g}$ confirma insuficiência pancreática exócrina ($< 100 \mu\text{g/g}$ indica forma grave), orientando a reposição enzimática.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

No DM tipo 3c prefere-se insulina, com atenção ao alto risco de hipoglicemia; evitam-se sulfonilureias e a metformina só é usada se tolerada e sem desnutrição.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A dor neuropática da pancreatite crônica é tratada com tricíclicos (amitriptilina) e/ou gabapentinoides (gabapentina/pregabalina); evita-se o uso crônico de AINEs.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Na agudização é fundamental excluir pancreatite aguda, pseudocisto e infecção — não se deve atribuir toda a dor à cronicidade sem investigar complicações.

SM24
Suporte ao Plantão Médico